تجمع الرياض الصحي الثاني
Riyadh Second Health Cluster

الأعراض النفسية التي تصيب مريض باركنسون

Psychological symptoms Affect a Parkinson's patient

الأعراض النفسية الشائعة التي تصيب مريض باركنسون:

١- الاكتئاب:

يمكن أن يتراوح من الشعور بالإحباط معظم الوقت إلى القنوط واليأس المسببان للعجز.

إن سبب الاكتئاب لدى مرضى داء باركنسون غير معروف.

قد يكون اكتئاباً تفاعلياً، يتفاعل مع تطوّر داء باركنسون.

قد يكون سببه التغييرات في كيمياء الدماغ المرتبطة بداء باركنسون. تنخفض نسبة الناقلات العصبية الدوبامين و السيروتونين في الدماغ، و كلاهما مهم للشعور بالسعادة و البهجة.

- علاج الاكتئاب شبيه بعلاج داء باركنسون:

معالجة أعراض داء باركنسون.

النوم الصحي والحرص على أدوية النوم. عالج الأرق إذا شعرت بحرمان من النوم، وتناول أدوية داء باركنسون قبل النوم أو خلال الليل إذا وُصف لك ذلك.

المشاركة في نشاطات اجتماعية واستجمامية و عمل التمارين.

تناول أدوية الاكتئاب الموصوفة من الطبيب المعالج.

المعالجة بالصدمة الكهربائية.

٢- القلق:

يعتبر القلق من الأعراض الشائعة لداء باركنسون.

قد يتراوح من مجرد توتر بسيط إلى القلق أو التوجس أو الهواجس بعدم التكافؤ مع الظروف إلى حالة قلق صريحة أو نوبات ذعر.

قد تتطور أعراض حركية أخرى بعد عدة سنوات.

قد يتطوّر في الوقت ذاته مع أعراض أخرى لداء باركنسون، لكنه يتطور عادة في مرحلة متقدمة من المرض.

إن حالات الذعر الحادة غير شائعة في داء باركنسون، لكنها قد تكون من الأعراض الأكثر إزعاجاً لدى البعض، تحصل عادة في فترات عدم عمل الدواء.

يستجيب القلق المرتبط بداء باركنسون لأدوية داء باركنسون إلى جانب الرُعاش و الهيئة والتباطؤ.

دوّن أوقات القلق، هل هذا الشعور يظهر و يختفي؟ هل النشويات (الكربوهيدرات) تساعد على تخفيض القلق؟

هل تظهر الأعراض عندما يقترب موعد الجرعة التالية لداء باركنسون أو في الليل عندما لا تتناول أي دواء؟

- علاج القلق:

تعديل أدوية داء باركنسون	إيجاد روتين يومي للاسترخاء
الابتعاد عن التفكير السلبي	القيام بنشاطات جسدية
التركيز على ما يمكنك فعله والابتعاد عن التفكير فيما لا يمكنك فعله	مكافأة لنفسك و إيجاد وسائل الراحة والمرح
العلاج النفسي والدعم	الأدوية

٣- التعب و الإجهاد:

غالباً ما يشكو مرضى باركنسون من التعب والإجهاد خلال مرحلة مبكرة من المرض، حتى قبل تطور الأعراض الحركية

في دراسة أجريت على المسنين في النرويج أظهرت أن ٤٤ % من مرضى داء باركنسون و ١٨ % من الأشخاص الأصحاء الذين أجريت عليهم الدراسة للمقارنة أبلغوا عن شعورهم بالتعب و الإجهاد.

قد يكون من أعراض النعاس أو الاكتئاب، لكنه قد يظهر من دون هذه الأمور

قد يُعتبر نقصاً في الطاقة و نقصاً في القدرة على التحمل

- علاج التعب والإجهاد:

قد تُساعد أدوية داء باركنسون ولو بشكل جزئي بمعالجة الاكتئاب و النعاس خلال النهار.

استبعاد الحالات الطبية الأخرى.

مراجعة قائمة الأدوية (مثل: بينادريل، كلونازيبام، بروبرانولول).

٤- اضطرابات السيطرة على الدوافع:

القمار القهري \ المرضي:

قد يكون متعلقاً بأدوية داء باركنسون، كما أن اضطراب السيطرة على الدوافع السلوكي قبل بداية داء باركنسون نادر.

قد تشمل الدوافع ألعاب ذات مبالغ منخفضة (ماكينات الحظ، أوراق الحك والكشط "امسح واربح").

عند حدوث هذه الأعراض الرجاء مراجعة الطبيب المعالج.

فرط الرغبة الجنسية:

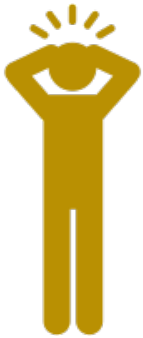
- قد تسبب أدوية داء باركنسون هوساً جنسياً يتجلى برغبة جنسية متزايدة، وغالباً ما تظهر لدى الرجال ولكنها نادرة.
- هذه الحالة أكثر شيوعاً بعد البدء بدواء جديد مثل مناهض الدوبامين، وقد تزول مع تخفيف الدواء.
- إذا لم تتم إضافة دواء جديد يجب مراجعة جميع الأدوية، فيما يتعلق بالهلوسات والأوهام، وإيقاف الأدوية غير الضرورية.

يمكن إضافة بعض الأدوية لتخفيف الشهوة الجنسية

- أعراض أخرى محتملة:

الشراء القهري، الطعام و الإضافات و الكماليات و الانهماك بالمهام.

السلوكيات النمطية (الانجذاب، الافتتان بالأشياء أو النشاطات التافهة و عديمة القيمة).



٥- الخمول:

قلّة الأداء والتفكير والمزاج الموجّه نحو هدف معيّن.

- يمكن حصوله مع الاكتئاب، لكن ثمة اعتقاد بأنه اضطراب مختلف يحصل لدى حوالي ١٠-٢٠ % من مرضى داء باركنسون من دون اكتئاب.

يجب التمييز بين خسارة الاهتمام الذي يميّز الخمول و خسارة المتعة التي تميّز الاكتئاب عادة

- مرتبط باعتلال إدراكي عام وربما اعتلال تنفيذي. من الشائع استخدام الأدوية مثل المنشطات، على الرغم من عدم وجود أي دراسة علاجية رسمية تدعم استخدامه.

٦- التفكير البطيء (تبلّد الذهن):

قد يتباطأ التفكير بسبب داء باركنسون، على غرار تباطؤ الحركة. يمكن للمريض إعطاء الإجابة الصحيحة لكن قد يتطلب وقتاً أطول.

هذا لا يشكل إشارة مبكرة للخرف. و لا يشير إلى أن هناك مشاكل إدراكية خطيرة ستحصل.

- علاج التفكير البطيء:

أدوية داء باركنسون.

٧- الخرف (النسيان المتكرر المرضي):

- قد يُصاب مرضى داء باركنسون بالخرف بنسبة تتراوح بين ١٠% و٥٠%. إذا تطوّر الخرف فتكون بدايته النموذجية بعد سنوات عدّة من تطوّر داء باركنسون.
- من المتوقع حصول الخرف أكثر لدى مرضى داء باركنسون الأكبر سناً، كما تبيّن لدى عامة المرضى.

- **علاج الخرف:**

يوصف عن طريق الطبيب المعالج.

٨- الأوهام و جنون الارتياب:

الأوهام:

هي معتقدات خاطئة وغريبة أحياناً وغالباً ما تكون غير منطقية. تظهر في مرحلة متأخرة من داء باركنسون وهي غير شائعة.

- قد تتراوح حدتها:

من	أوهام لا تسبب المشاكل (كانتظار ضيوف على العشاء).
إلى	أوهام خطيرة (كاعتقاد أن الزوج/الزوجة خائن/ة).

جنون الارتياب:

عبارة عن الأوهام التي تتميّز بالارتياب/الشك والاضطهاد. وقد يشمل ذلك أفراد العائلة والأصدقاء (محاولة سرقة المال)، أو الشرطة (التجسس عليهم).

- العلاج:

يصبح العلاج ضرورياً عندما تصبح الأفكار غريبة وتؤثر على الحياة والعلاقة مع الآخرين العلاج يشبه علاج الهلوسات.

راجع كافة الأدوية مع طبيبك و خفف أو ألغِ الأدوية غير الضرورية

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم الإعالة العالية والأعصاب

King-fahad-medical-city

@Kfmc_Riyadh

KfmcRiyadh

8001277000

HEM1.18.000385